

Проведение скрининговых осмотров по раннему выявлению онкологических заболеваний в Павлодарской области в 2011 году

Жылкайдарова А.Ж., Баймаханов Т.Б., Сулейменов М.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, Павлодарский областной центр формирования здорового образа жизни, Павлодарский областной онкологический диспансер

Актуальность

Одним из направлений Государственной программы развития здравоохранения на 2011-2015 гг. является усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации основных социально-значимых заболеваний. В этой связи запланировано развитие Национальной скрининговой программы. Ее реализация позволит спасти жизни тысячи наших соотечественников и сделать существенный вклад в экономику нашей страны в виде сокращения прямых и косвенных потерь общества от болезней и преждевременной смерти граждан.

Скрининговые осмотры по раннему выявлению рака молочной железы и шейки матки внедряются с 2008 года. В течение этого времени принимаются меры по совершенствованию программ раннего выявления злокачественных новообразований.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов скрининговых осмотров за 6 месяцев 2011 года. За отчетный период было осмотрено 7307 женщин в возрасте 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет, что составляет 52,7% к запланированному числу. Три четверти (5513 женщин) составили жительницы гг. Павлодар, Аксу и Экибастуза (рисунок 1). Наибольшее количество сельских

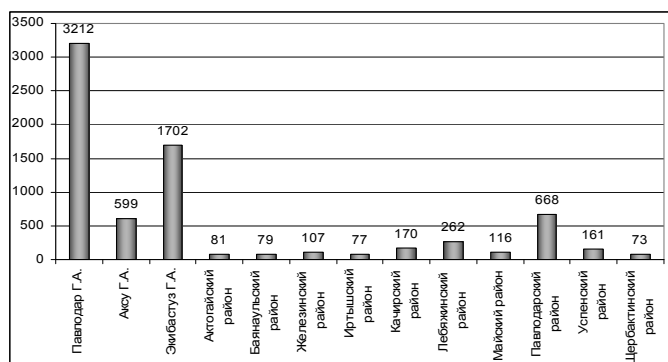


Рисунок 1. Количество осматриваемого населения в ходе скринингового обследования на раннее выявление заболеваний молочной железы за 6 месяцев 2011 года в разрезе по Павлодарской области.

жителей, прошедших маммографическое обследование, проживали в Павлодарском (668) и Лебяжинском (202) районах. Реже всего маммографический скрининг проходили жительницы Щербактинского (73), Иртышского (77), Баянаульского (79) и Актогайского (81) районов.

За 6 месяцев 2011 года осмотрено 10636 женщин в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 для выявления заболеваний шейки матки, что составило 52,9% к запланированному объему. Из числа осматриваемых 72,2% (7681) составили городские жительницы. Наибольшее количество сель-

В работе представлены результаты проведения скринингов в Павлодарской области за 6 месяцев 2011 года. По скринингу РМЖ осмотрено 7307 женщин целевой группы, выявлено 2 случая рака молочной железы (0,3% от числа обследованных). По скринингу РШМ осмотрено 10636 женщин, РШМ установлен у 4 женщин, что составляет 0,04%. По колоректальному скринингу гемокульт тест проведен лишь 342 пациентам, у всех тест был отрицательным. Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию скрининговых осмотров в регионе.

Жұмыста 2011 жылдың 6 айында Павлодар облысында өткізілген скрининг қорытындылары ұсынылған. Сүт безі рагы бойынша мақсатты топтың 7307 әйелі қаралып, сүт безі қатерлі ісігінің 2 жағдайы анықталған (бұл тексерілгендердің 0,3% үлесін құрайды). Жатыр мойны рагына 10636 әйел тексеріліп, ауру 4 әйелде анықталды, яғни пайыздық үлесі - 0,04%. Колоректалды қатерлі ісігін анықтау бойынша гемокульт тест тек 342 емделушіге жасалып, ауру анықталмады. Сонымен бірге мақалада аймақта скринингтік тексерісті жетілдіру бойынша ұсыныстар да келтірілген.

The results of cancer screening in Pavlodar oblast for 6 months 2011 are presented. Breast cancer screening involved 7307 women from target group. 2 cases of a breast cancer (0,3 %) are detected. Cervical cancer screening involved 10636 women, 4 women (0,04%) had diagnosis of cancer. Colorectal screening by haemocult-test involved only 342 patients, the test was negative in all cases. Offers for further screening improvement in region are suggested.

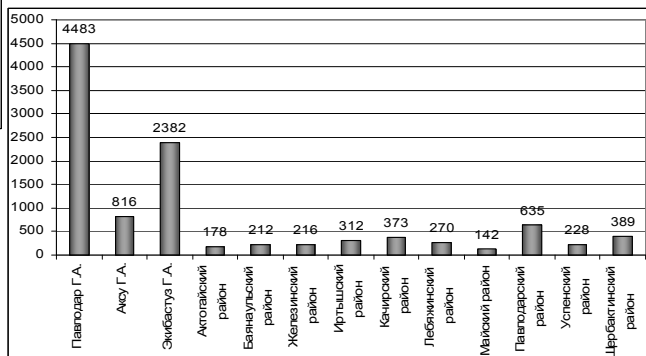


Рисунок 2. Количество осматриваемого населения в ходе скринингового обследования на раннее выявление заболеваний шейки матки за 6 месяцев 2011 года в разрезе по Павлодарской области.

ских жительниц было осмотрено в Павлодарском (635), Щербактинском (389), Качирском (373) и Иртышском (312)

районах. Наименьшее количество прошедших цитологический скрининг было в Майском (142) и Актогайском (178) районах (рисунок 2).

За отчетный период обследование по раннему выявлению заболеваний толстой и прямой кишки путем определения скрытой крови в кале проведено 342 пациентам в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет. Исследование проведено путем использования бензидиновой пробы, что не соответствует требованиям приказа МЗ РК от 16 марта 2011 года № 145 по проведению скрининговых осмотров. Согласно данного приказа, определение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) должен проводиться иммунохимическим методом (iFOBT-тест).

Результаты

Скрининг на раннее выявление доброкачественных и злокачественных новообразований молочной железы.

У 8,5% из числа обследованных женщин была выявлена опухолевая патология молочной железы различного характера. Как представлено на рисунке 3, наиболее часто данная патология выявлялась у жительниц г.Экибастуза (26,7%), Железинского (15,9%), Успенского (11,8%) и Качирского (10%) районов. Ни одного случая патологической маммографии не было отмечено в Актогайском, Иртышском, Майском, Щербактинском районах.

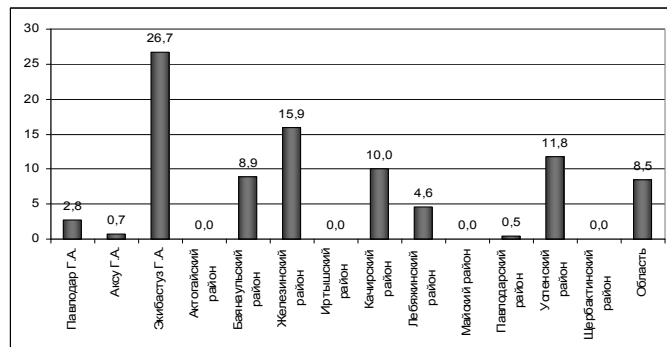


Рисунок 3. Процент выявленных больных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями молочной железы по результатам 6 месяцев 2011 года, в разрезе по Павлодарской области.

По данным маммографического скрининга за 6 месяцев 2011 года выявлено 2 случая рака молочной железы (0,3% от числа обследованных). Из них у одной женщины выявлена опухоль до 1 см, у другой – свыше 1 см.

Скрининг на раннее выявление предопухолевых и злокачественных заболеваний шейки матки.

В целом по области выявлено 264 случая патологии шейки матки, что составило 2,5% к числу осмотренного населения (рисунок 4). Самый высокий уровень данной патологии выявлен в Баянаульском районе – 40 женщин из 212, то есть почти каждая пятая женщина имеет заболевание шейки матки (18,9%). Несмотря на большой объем осматриваемых женщин, уровень выявляемости в гг.Павлодар, Аксу и Экибастуз составил от 1,3% в г.Павлодаре, что ниже среднеобластного значения, до 4% в г.Экибастузе. Среди сельских районов Высокий уровень выявления патологии шейки матки, после Баянаульского района, отмечен в Качирском районе (3,2%), далее следуют Щербактинский (2,1%), Железинский (2%) и Иртышский (1,6%) районы.

В таблице 1 представлена информация о результатах цитологического скрининга. Как видно из представленной таблицы, наибольший процент патологии приходится на воспалительные заболевания шейки матки (18,2%).

По результатам проведенного цитологического скрининга патология HSIL выявлена у 43 женщин (0,4%), LSIL – у 346 (3,2%).

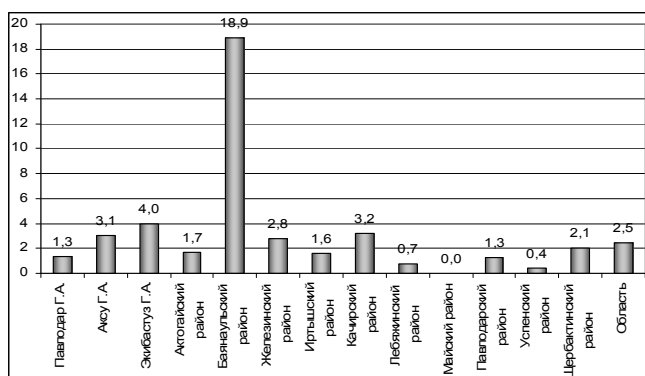


Рисунок 4. Процент выявленных больных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года, в разрезе по Павлодарской области.

Таблица 1 - Выявленная патология шейки матки по результатам 6 месяцев 2011 года.

Патология шейки матки	В ы я в л е н а патология, абс.число	% к числу осматриваемых
Дисплазия I ст	346	3,2%
Дисплазия II ст	43	0,4%
Дисплазия III ст	1	0,01%
Подозрение на рак	0	
Рак	4	0,04%
Воспалит. заболевания шейки матки	1987	18,2 %
Пролиферация железистого эпителия	98	0,9%

Рак шейки матки установлен у 4 женщин, что составляет 0,04% и соответствует республиканскому показателю за отчетный период (0,04%). Процент выявленной патологии был бы выше при соблюдении правил забора и фиксации мазков в ЛПО области. При посещении ЛПО выявлено отсутствие мединструментария для забора мазков и факты неправильной фиксации их. Все женщины с выявленной тяжелой дисплазией вызываются к гинекологу областного онкодиспансера, проводится биопсия и санация.

Скрининг на раннее выявление предопухолевых и злокачественных заболеваний толстой и прямой кишки.

В результате использования бензидиновой пробы ни у одного из 342 обследованных не было выявлено положительной пробы.

Обсуждение

Несмотря на проведенные организационно-методические мероприятия, информационную работу с населением и медицинскими работниками ПМСП, существуют следующие проблемы, которые необходимо решить для повышения результативности скринингов и показателей раннего выявления злокачественных новообразований..

Во-первых, не определены количественные показатели целевых групп, подлежащих скрининговому осмотру до конца текущего года. В связи с этим, не представляется возможным оценить полноту охвата целевой группы населения. Исключение составляют целевые группы по скринингу заболеваний шейки матки и молочной железы.

Во-вторых, не в полной мере обеспечены скрининговые осмотры соответствующим оборудованием и расходными материалами. Нехватка штатов (рентгенологов для «вто-

рой» читки маммограмм, цитологов) в онкологическом диспансере являются серьезным сдерживающим фактором в повышении эффективности скрининговых осмотров.

В-третьих, не до конца сформировано программное обеспечение обработки результатов скрининговых осмотров, что не позволяет дать более развернутый анализ и характеристику результатов обследований.

В-четвертых, следует продолжать процесс обучения специалистов, участвующих в скрининговых осмотрах. Так, например, некачественное взятие материала при цитологическом скрининге, значительно увеличивает время проведения обследования и в целом негативно влияет на имидж скрининговых осмотров.

Правила оформления рукописей для журнала «Онкология и радиология Казахстана»

- Формат рукописи - А4.
- Текст должен быть написан в программе Word с использованием шрифта Times New Roman, кеглем 14, с пробелами полуторными.
- Статья подается на CD-диске со вкладышем, на котором обозначается имя автора и название статьи.
- Объем рукописи: научная статья - до 5 стр, случай из практики - 3-4 стр.; обзор, лекция - не более 8 стр.
- Список литературы - минимально необходимый.
- Рукопись визируется руководителем учреждения (кафедры), научным руководителем, скрепляется печатью.
- К рукописи прилагается резюме на казахском, русском, английском языках, ключевые слова, УДК.
- В конце рукописи - сведения об авторах: степень, должность, количество имеющихся публикаций.
- Адрес, телефоны (можно и мобильный), электронная почта.
- Рукопись подписывается лично автором как свидетельство полной аутентичности данных материала, ответственности автора за содержание рукописи.